

精神科検査法

1. 心理検査
2. 症状評価尺度
3. 画像検査
4. 生理検査

名古屋市立大学 精神・認知・行動医学分野
利重 裕子・渡辺 孝文・中口 智博

1. 心理検査

心理検査 総論

- 主観的な精神症状をできるだけ客観的に把握するための手段として**心理検査**が作成される
- 誰が検査しても、誰に対して同じ検査を何度行っても同一の結果が再現される**信頼性** (reliability) と、その検査が意図した対象を測定しているのかどうかという**妥当性** (validity) が検証されていて、題材や手技が定まっており、評価方法が確立されたものを**標準検査**と呼ぶ

心理検査 総論

- 精神科領域の診断・病態評価の補助に用いる
 - 精神疾患では確立したバイオマーカーがないため、検査は心理検査のみ(認知症疾患、器質性疾患、てんかんを除く)
- 心理検査の特徴
 - 一定の手続き ⇒ より再現性のある客観的な情報
 - 検査の組合せ ⇒ 短時間で多面的な情報
 - 結果を数量化 ⇒ 個人間・グループ間で比較可能

心理検査の分類

- 知能検査・発達検査
- 神経心理学的検査（高次脳機能検査）
- パーソナリティ検査（性格検査）

※個々の心理検査の特性を考慮しながら、目的に応じて選択し、組み合わせて施行する（テストバッテリー）

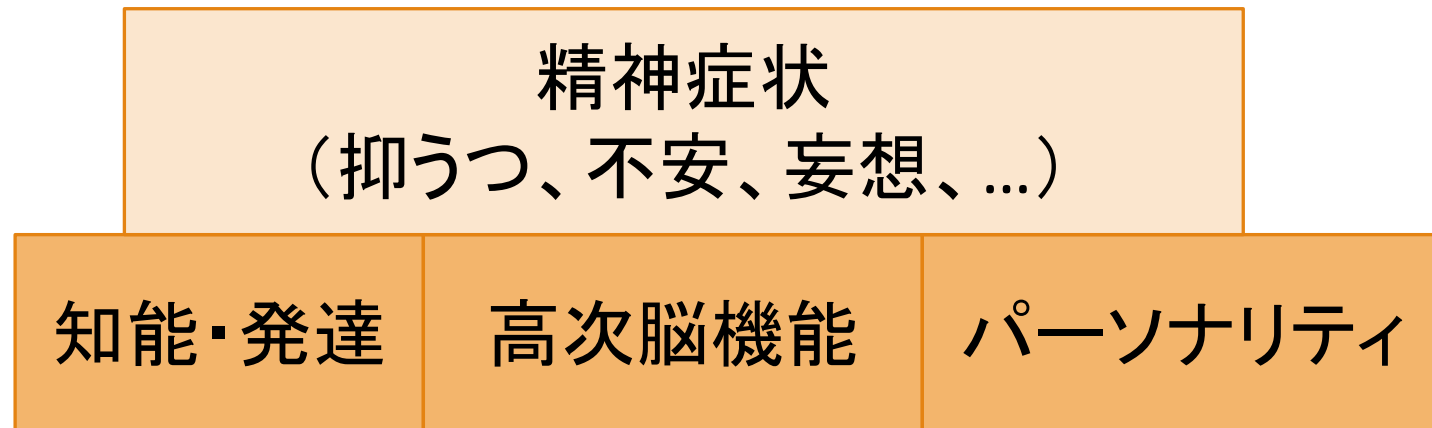
心理検査、症状評価尺度の関係

- 心理検査

- 精神疾患の「土台」となる「人となり」を評価する

- 精神症状評価尺度

- 妄想、気分、不安などの精神症状を評価する



知能検査

知能検査の主な種類

ウェクスラー法

- **WAIS-IV**： 成人用 16歳0カ月～90歳11カ月
- **WISC-V**： 小児用 5歳0カ月～16歳11カ月
- **WPPSI-III**： 幼児用 2歳6カ月～7歳3カ月

- 田中ビネ一式知能検査：2歳0カ月～成人

WAIS-IV:

ウェクスラー成人知能検査

Wechsler Adult Intelligence Scale-fourth edition

- **Wechsler Intelligence Scale (Wechsler, 1939)に始まり、改訂が重ねられた**
- **適用年齢: 16～90歳**
- **施行時間: 60～90分**
- **保険点数: 450点**
- **Wechsler氏は、知能を環境適応力と理解**
- **異なる能力の項目別評価を行う**

WAIS-IV: ウェクスラー成人知能検査

Wechsler Adult Intelligence Scale-fourth edition

- 全検査IQ(平均100、標準偏差15)を算出
- WAIS-IVでは言語理解、知覚推理、ワーキングメモリー、処理速度の4つの領域で能力を評価
- 領域別の能力落差や強み弱みを判定
- 個人内の能力のバランスを詳しく分析

WAIS-IVの特徴： 4つの下位指標も算出可能

全検査IQ（**FSIQ**: Full Scale Intelligence Quotient）

言語理解（**VCI**: Verbal Comprehension Index）

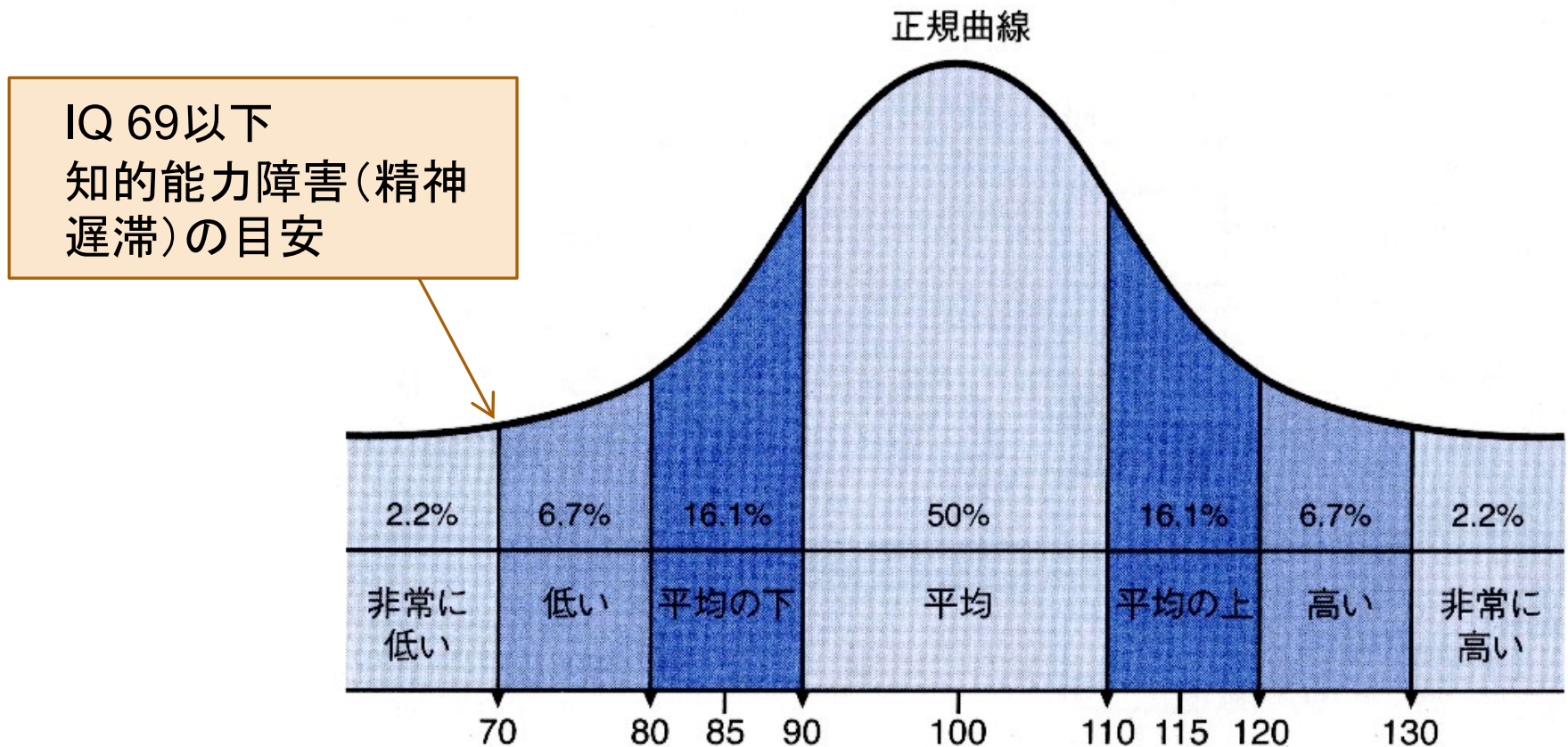
知覚推理（**PRI**: Perceptual Reasoning Index）

ワーキングメモリー（**WMI**: Working Memory Index）

処理速度（**PSI**: Processing Speed Index）

WAIS-IVの特徴： 標本に基づいて標準化されている

被験者の帰属する同一年齢集団の平均値からのズレ(偏差)で表す「偏差IQ」を採用



WAIS-IV 記録用紙(日本文化科学社)

言語理解（VCI）

- 言葉の理解力・表現力・推理力の指標

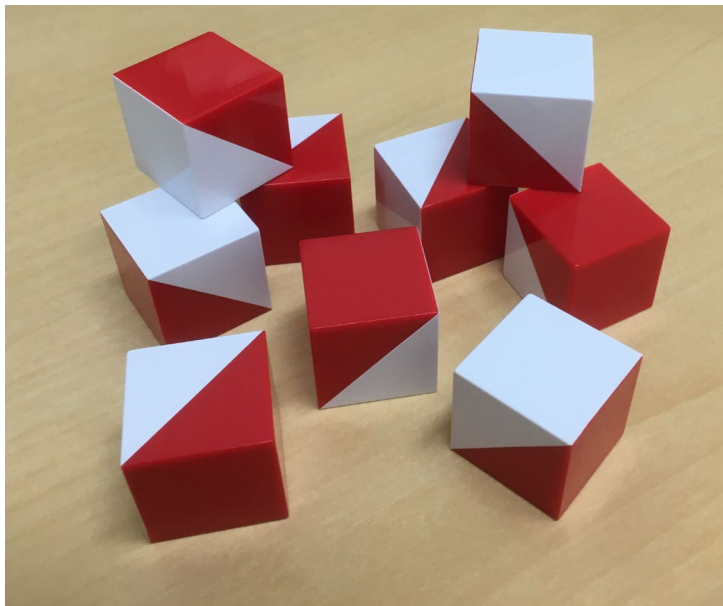
類似	2つの言葉の類似点を答える 例) つぼみ – 赤ちゃん 例) 許可 – 制限
単語	絵の名称や単語の意味を答える 例) バリアフリー 例) 婉曲
知識	一般的な知識に関する質問に答える 例) マハトマ・ガンジーとはどのような人物ですか

知覚推理 (PRI)

- 流動性推理 (新しい場面へ適応するための推理力) や視覚情報処理能力を反映する指標

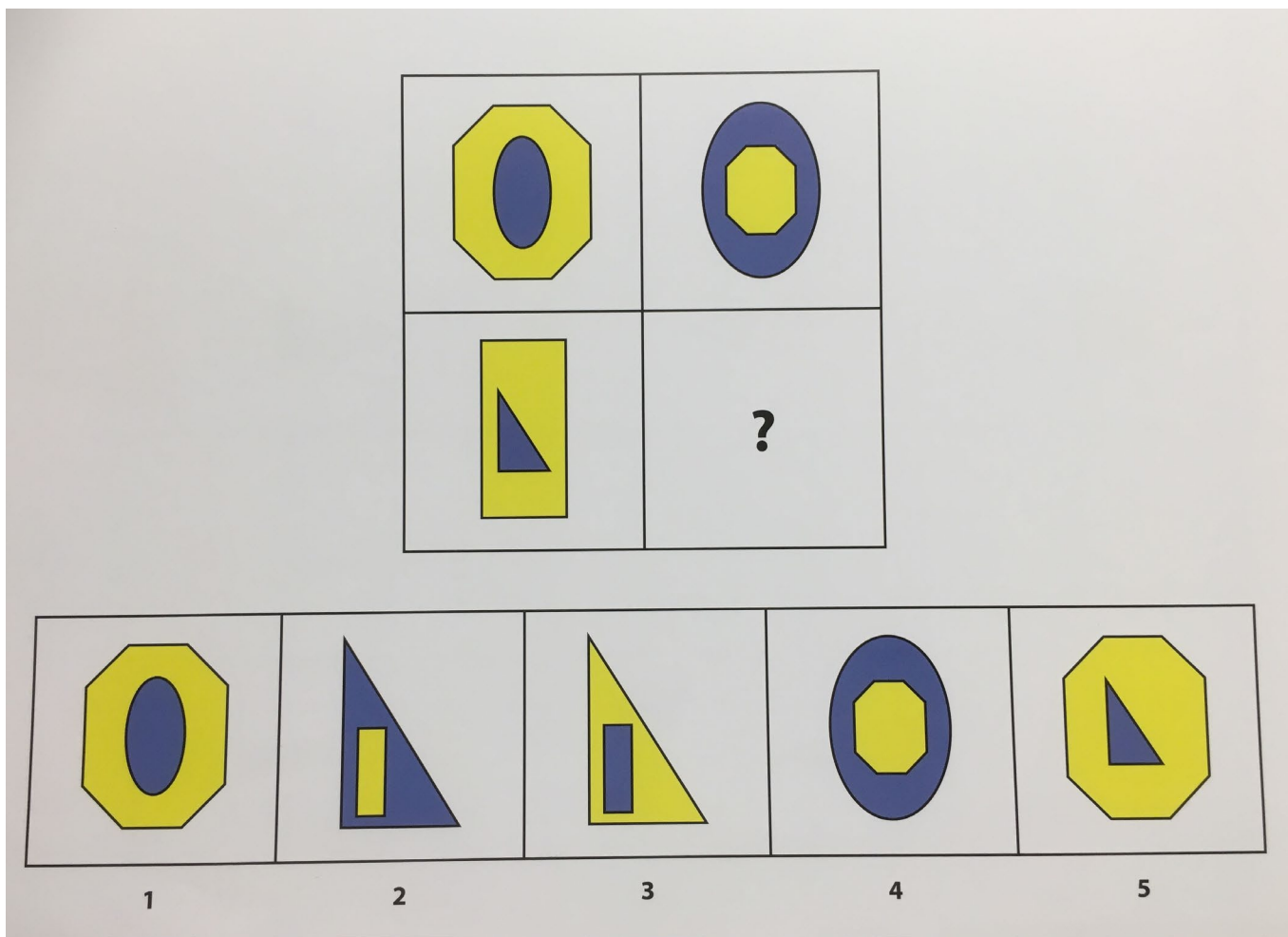
積木模様	見本の模様を、積木を使って作る
行列推理	不完全な行列・系列から法則性を見つける
パズル	見本の図形を構成できる3つのピースを選ぶ

積木模様

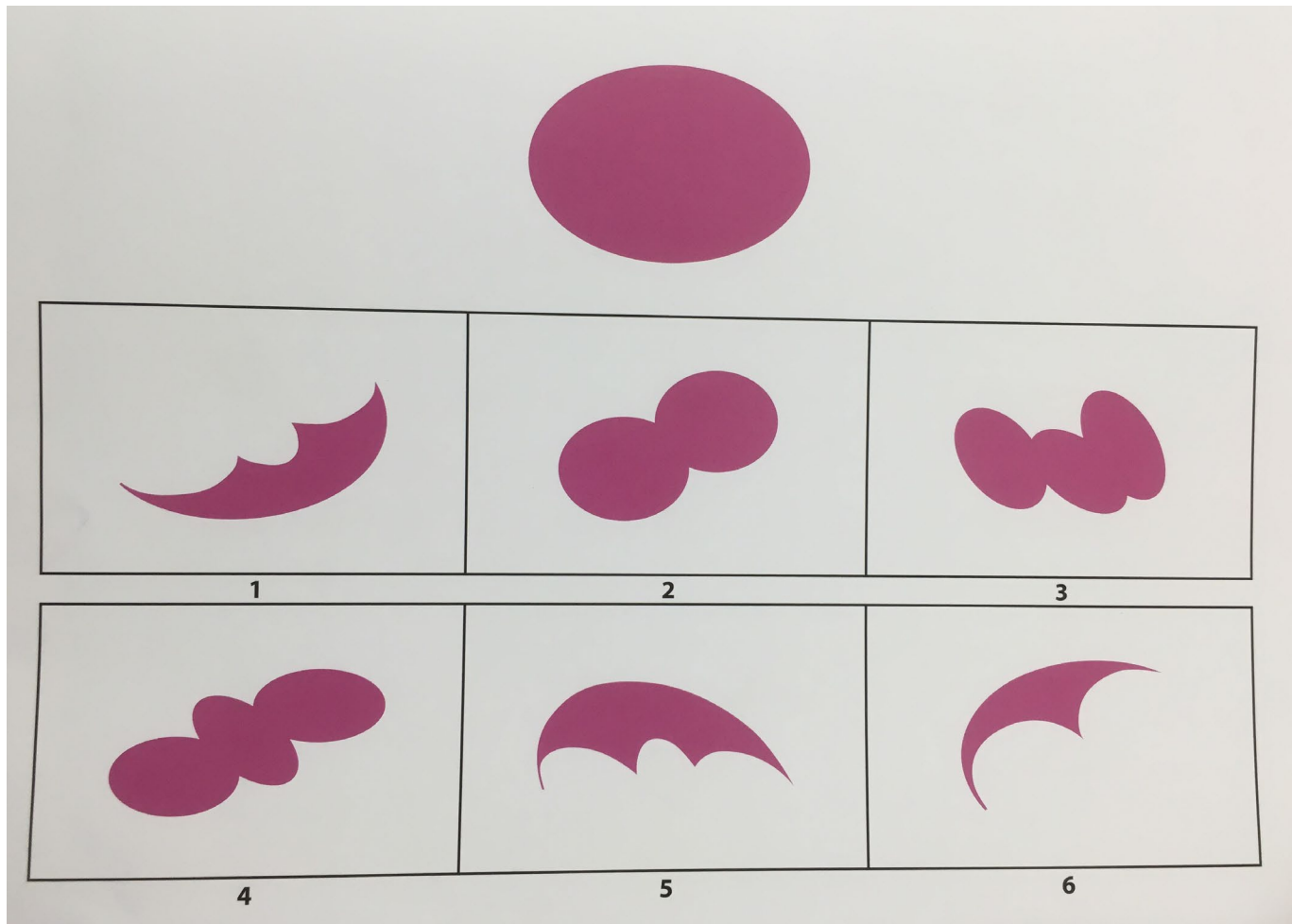


WAIS-IV 検査キット(日本文化科学社)

行列推理



パズル



WAIS-IV 検査キット(日本文化科学社)

ワーキングメモリー (WMI)

- 注意を集中させて聴覚情報を記憶し、その情報を頭の中で操作・処理する能力

数唱	順唱: 同じ順番で答える 逆唱: 逆の順番で答える 数整列: 昇順に並べ替えて答える 例) 6 - 2 - 5 - 2 - 3 - 4 $\Rightarrow$ 2 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
算数	算数の文章題を暗算で答える 例) いつも60球ボールを打つ人がいます。今日はいつもより15%少ない数しか打ちませんでした。今日は何球打ちましたか。

処理速度（PSI）

- 目と手を協応させて単純な作業を正確にこなす能力

記号探し	刺激記号がグループの中にあるかを判断する
符号	数字と対になっている記号を書き写す

記号探し

$\oplus$	$\ominus$	$\oplus$	∇	$\pm$	$\square$	$\leadsto$	ない
$\neq$	$\boxplus$	$\cup$	$\boxplus$	∇	$\triangleright$	$\pm$	ない
$\leadsto$	$\angle$	$\odot$	$\triangleright$	$\lrcorner$	$\approx$	$\neq$	ない

符号

1	2	3	4	5	6	7	8	9
└	┐	∧	—		┌	┐	└	┐

6	8	3	9	5	4	1	7	2	1	4	8	2	7	6	9	3	5
8	3	1	9	2	5	6	4	3	7	2	9	8	1	4	7	6	5

結果の分析

② 粗点から評価点への換算

下位検査	粗点	評価点				基準 年齢群 評価点
積木模様	48	9	9			8
類 似	27	12	12			13
数 唱	28	10		10		10
行列推理	17	9	9			8
単 語	37	13	13			14
算 数	17	11		11		11
記号探し	35	8			8	8
パズル	15	8	8			7
知 識	19	12	12			13
符 号	83	9			9	9
(語音整列)*		()		()		()
(バランス)*		()	()			()
(理 解)	25	(12)	(12)			(12)
(絵の抹消)*	36	(9)			(9)	(9)
(絵の完成)		()	()			()
④ 評価点合計	101	37	26	21	17	

*16-69歳のみ

全検査 言語理解 知覚推理 ワーキングメモリー 処理速度

⑤ 評価点合計から合成得点への換算

	評価点 合計	合成得点	パーセン タイル	信頼区間* 90% / 95%
全検査	101	FSIQ 101	53	97-105
言語理解	37	VCI 113	81	107-118
知覚推理	26	PRI 91	27	86-98
ワーキングメモリー	21	WMI 103	58	97-109
処理速度	17	PSI 90	25	84-98

*信頼区間を計算するために使用したSEMIについては、理論・解釈マニュアルの表4.3に掲載されている。

Copyright © 2008 NCS Pearson, Inc. Japanese translation copyright © 2018 NCS Pearson, Inc. All rights reserved. Adapted and distributed by Nihon Bunka Kagakusha under exclusive license from NCS Pearson, Inc. 原著作権 © 2008年 NCS Pearson, Inc. 日本著作権 © 2018年 NCS Pearson, Inc. すべての権利を留保しています。NCS Pearson, Inc. の独占的ライセンスのもと、日本文化科学社が翻案、販売します。

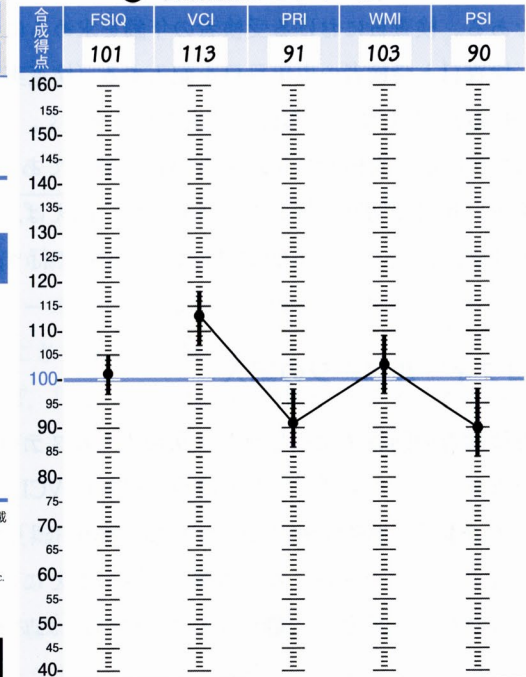
日本文化科学社
www.nichibun.co.jp

PEARSON

⑥ 下位検査の評価点プロフィール

	言語理解				知覚推理				ワーキングメモリー			処理速度			
下位検査	類似	単語	知識	理解	積木模様	行列推理	パズル	バランス	絵の完成	数唱	算数	語音整列	記号探し	符号	絵の抹消
	12	13	12	12	9	9	8			10	11		8	9	9
19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

⑦ 合成得点プロフィール



WAIS-IV 実施・採点マニュアル

(日本文化科学社)

② 粗点から評価点への換算

下位検査	粗点	評価点					基準 年齢群 評価点
積木模様	48	9		9			8
類 似	27	12	12				13
数 唱	28	10			10		10
行列推理	17	9		9			8
単 語	37	13	13				14
算 数	17	11			11		11
記号探し	35	8				8	8
パズル	15	8		8			7
知 識	19	12	12				13
符 号	83	9				9	9
(語音整列)*		()			()		()
(バランス)*		()		()			()
(理 解)	25	(12)	(12)				(12)
(絵の抹消)*	36	(9)				(9)	(9)
(絵の完成)		()		()			()

④ 評価点合計 101 37 26 21 17

*16-69歳のみ

全検査 言語理解 知覚推理 ワーキングメモリー 処理速度

⑤ 評価点合計から合成得点への換算

評価点	合成得点	パーセン	信頼区間*
-----	------	------	-------

⑥ 下位検査の評価点プロフィール

下位検査	言語理解				知覚推理				ワーキングメモリー			処理速度			
	類似	単語	知識	理解	積木模様	行列推理	パズル	バランス	絵の完成	数唱	算数	語音整列	記号探し	符号	絵の抹消
	12	13	12	12	9	9	8			10	11		8	9	9
19	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
14	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

⑦ 合成得点プロフィール

合成得点	FSIQ	VCI	PRI	WMI	PSI
	101	113	91	103	90
160-					
155-					
150-					
145-					
140-					
135-					
130-					
125-					

4	評価点合計	101	37	26	21	17
*16-69歳のみ		全検査	言語理解	知覚推理	ワーキングメモリー	処理速度

⑤ 評価点合計から合成得点への換算

	評価点 合計	合成得点	パーセン タイル	信頼区間* 90% / 95%
全検査	101	FSIQ 101	53	97-105
言語理解	37	VCI 113	81	107-118
知覚推理	26	PRI 91	27	86-98
ワーキングメモリー	21	WMI 103	58	97-109
処理速度	17	PSI 90	25	84-98

* 信頼区間を計算するために使用したSEMについては、理論・解釈マニュアルの表4.3に掲載されている。

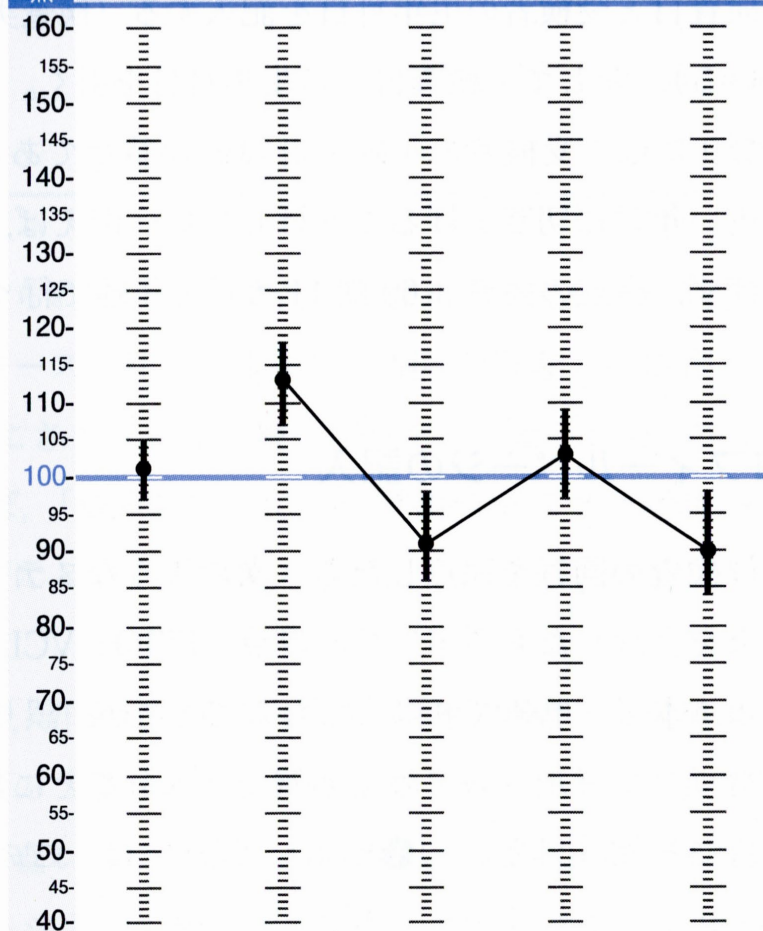
Copyright © 2008 NCS Pearson, Inc. Japanese translation copyright © 2018 NCS Pearson, Inc. All rights reserved. Adapted and distributed by Nihon Bunka Kagakusha under exclusive license from NCS Pearson, Inc.

原著著作権 © 2008年 NCS Pearson, Inc. 日本版著作権 © 2018年 NCS Pearson, Inc. すべての権利を留保しています。NCS Pearson, Inc. の独占的ライセンスのもと、日本文化科学社が翻案、販売します。

6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

⑦ 合成得点プロフィール

合成得分	FSIQ	VCI	PRI	WMI	PSI
	101	113	91	103	90



WAIS-IV ディスクレパンシー比較

- 下位指標の差を分析できる
- 患者の得意・不得意を知る
 - 診断的情報： 発達障害の補助的な評価になる
 - 支援に役立つ情報

子ども用のウェクスラー式知能検査

- **WISC-V** (Wechsler Intelligence Scale for Children)
 - 適用年齢: 児童用 5～16歳
 - 施行時間: 60分程度
 - 言語理解、視空間、流動性推理、ワーキングメモリー、処理速度の5つの領域で能力を評価
- **WPPSI-III** (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence)
 - 適用年齢: 幼児用 2～7歳
 - 施行時間: 60分程度
 - 就学前の子どもへのアセスメントのニーズに応えるための検査

田中ビネー式知能検査

- Binetが児童用の知能検査を1905年に開発
- 1937年に日本で標準化(現在は2003年改訂版)
 - 13歳以下では、問題が難易度順に配列されており、どの問題まで正答できるかによって「精神年齢」を求め、「生活年齢」で割ってIQを算出する(比例IQ)
 - 14歳以上では17の下位検査を実施し、偏差IQ(平均100、標準偏差16)を算出
 - 保険点数:280点
 - 田中ビネー式知能検査は、療育手帳の申請等でIQなどの数値が必須なときや、言語のやりとりが難しい or 中等度以上の知的能力障害が疑われる方には推奨される
- 特徴
 - 13歳以下ではIQしか算出できず、知能の内容はわからない

発達検査

発達検査

- 児童相談所・保健所などで用いられる
- 直接、子どもを検査するもの
 - 新版K式発達検査2001
 - 遠城寺式乳幼児分析的発達検査
- 養育者の面接により、間接的に検査するもの
 - 津守・稲毛式乳幼児精神発達検査

新版K式発達検査2001

- 発達指数(発達年齢÷生活年齢×100)で結果を示す
- 生後100日頃から満12～13歳頃までが適用年齢
- 所用時間:約30分
- 発達指数の算出には歩行など身体機能に関する評価が含まれており、厳密には知能指数とは異なる
- 3領域(姿勢・運動、認知・適応、言語・社会)で評価

遠城寺式乳幼児分析的発達検査

- 乳幼児発達の傾向を全般的にわたって分析し、その子の発達の個性を見いだすことを目的にしている
- 特に心身障害児の発達状況比較的簡単に検査し、発達グラフに表し、一見して発達障害の部位や程度を把握できる
- 適用年齢：0カ月～4歳8カ月
- 所用時間：約15分

津守・稲毛式乳幼児精神発達検査

- 乳幼児の日常生活行動を観察して「運動」「探索」「社会」「生活習慣」「言語」の5領域について測定できる
- 適用年齢：0～7歳
- 所用時間：約20分
- 養育者の面接により、間接的に検査するもの

国試過去問(第111回G問題9)

心理・精神機能検査のうち、直接患者に行わないのはどれか。

- a. 津守・稲毛式発達検査
- b. 田中・Binet式知能検査
- c. 状態特性不安検査〈STAI〉
- d. Minnesota多面人格検査〈MMPI〉
- e. Mini-Mental State Examination 〈MMSE〉

国試過去問(第111回G問題9)

心理・精神機能検査のうち、直接患者に行わないのはどれか。

- a. 津守・稲毛式発達検査
- b. 田中・Binet式知能検査
- c. 状態特性不安検査〈STAI〉
- d. Minnesota多面人格検査〈MMPI〉
- e. Mini-Mental State Examination 〈MMSE〉

神経心理学的検査

- 高次脳機能に関する検査
- 頭部外傷、脳血管障害後遺症、認知症性疾患などで実施

神経心理学的検査

- 私たちは、多くの情報を視覚や体性感覚などを通して知覚し「認識」しているが、この「認識」して活動に活かすための機能を「**認知機能**」と総称している
- 脳が何らかの外的要因で影響を受けたり、障害を受けるなどして認知機能が障害された状態を「**認知機能障害**」といい、「**認知機能の評価**」や「**認知機能障害の程度の評価**」を目的として行われる検査の総称が「**神経心理学的検査**」である

認知機能と認知機能障害

- 記憶障害
- 注意障害
- 遂行機能障害
- 視空間認知機能障害 等

記憶障害

記憶障害	症状の内容・例
前方性健忘	新しいことが学習できない、定着しない等
逆行性健忘	たとえば頭部受傷以前の記憶の障害など
展望記憶障害	未来に予定されたタスクやアクションを覚えておき、適切な時に実行することができない(病院の受診を忘れる等)
エピソード記憶障害	自分の個人的な出来事に関する記憶の障害
意味記憶障害	意味記憶とは、言葉の意味や公式などのようないわゆる知識として覚えている記憶(太陽が昇る方角がわからない等)
ワーキングメモリの障害	電話番号の復唱ができない
メタ記憶障害	自身の記憶の能力についての認識の障害

記憶障害の神経心理学的検査

検査名	
ウェクスラー記憶検査(WMS-R)	日本版が標準化されている。16～74歳が対象。検査道具を使用して40～60分程度の施行時間を要する。30分の遅延再生項目を含む計13の下位検査項目で成り立つ。国際的にもっとも頻用される記憶検査
リバーミード行動記憶検査(RBMT)	日常生活で支障をきたしそうな場面を想定した検査。日本版が標準化されている。展望記憶の評価ができるのが大きな特徴。所要時間約30分。 39歳以下、40～59歳、60歳以上の群分け実施が可能
MMSE (Mini Mental State Examination)	認知症のスクリーニング検査として国際的に広く使われている。所要時間約10分。30点満点でカットオフ値は23/24と定められている。
改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)	日本独自の認知症のスクリーニング検査。所要時間10分前後。30点満点でカットオフ値は19/20。 高齢者以外の対象や頭部外傷等の記憶障害の評価に用いる場合の結果の解釈は慎重にすべき。

WMS-R: ウェクスラー記憶検査

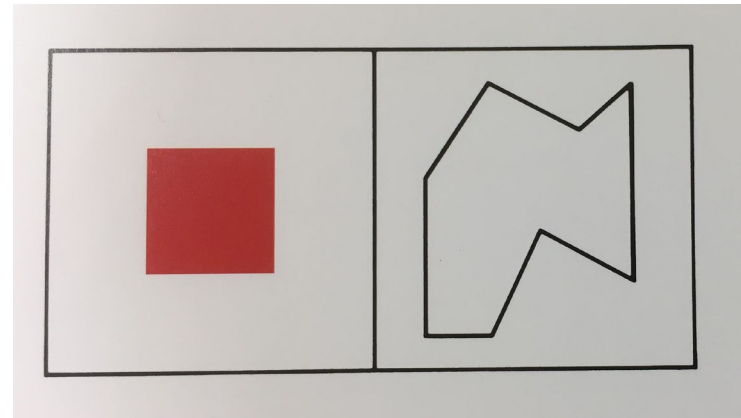
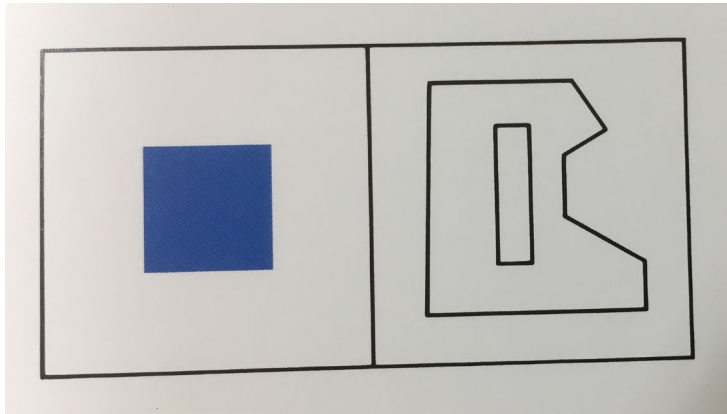
Wechsler Memory Scale-Revised

- 記憶の主な側面を総合的に測定(11項目)

情報と見当識	数唱
精神統制	視覚性記憶範囲
図形の記憶	論理的記憶II(遅延再生)
論理的記憶I(直後再生)	視覚性対連合II(遅延再生)
視覚性対連合I(直後再生)	言語性対連合II(遅延再生)
言語性対連合I(直後再生)	視覚性再生II(遅延再生)
視覚性再生I(直後再生)	

- 例) 視覚性対連合

- 色と対になった図形を提示 ⇒ 図形だけを見て色を答える



注意障害

注意障害	症状の内容・例
全般的注意障害(持続性注意障害)	注意や集中力の障害、疲れやすい等
全般的注意障害(選択性注意障害)	必要な情報の選択の障害 たくさんの情報から必要な情報を選べない
全般的注意障害(分配性注意障害)	同時処理の障害 複数のことに同時に注意を向けて並行して作業をすることができない等
全般的注意障害(転換性注意障害)	注意の切り替えの障害 注意を向けている対象から他の対象に注意を移せない等
方向性注意障害(半側空間無視)	

注意障害の神経心理学的検査

- CATS
- TMT
- Stroop Test

・1935年にStroopが開発。注意や前頭葉機能の干渉抑制機能を評価する検査

・日本語版でよく使われるものでは、**Part I** ではドットの色を読み上げる(統制条件)。**Part II** では、単漢字(川、田 etc)に染めてある色を読み上げる。**Part III** では、色の漢字(青、赤、黄、緑)に染めてある色を読み上げる(干渉課題)等の構成から成る。Part I ~ IIIで「読み上げにかかった時間」と「誤答数」を評価の対象として結果を解釈する。

遂行機能障害

- 見通しが立てられない
- 計画性がなくなる
- 選択ができない 等

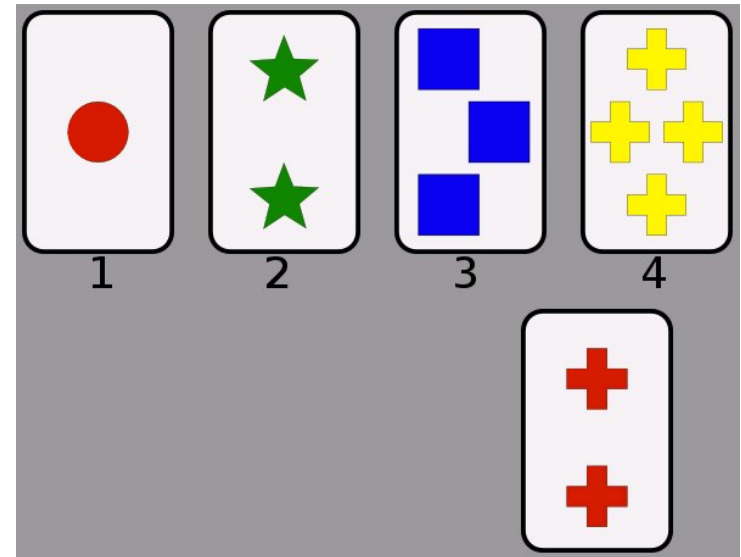
遂行機能障害の神経心理学的検査

- BADS (behavioural assessment of the dysexecutive syndrome)
 - ・1996年にWilsonらが開発。日本版も標準化されている。
 - ・日常生活の遂行機能障害の評価を目的とし、6つの下位検査から成る。
 - ・所要時間は60分程度。
- ウィスコンシンカード分類検査(WCST)
 - ・1984年にGrantとBergが開発し、1985年に鹿島らが日本版を開発。
 - ・注意や概念の転換の評価を目的として用いる。
 - ・本来はカード分類検査であったが現在はパソコンによる検査が可能。
- ハノイの塔

ウィスコンシンカード分類テスト

Wisconsin Card Sorting Test

- 前頭葉機能の検査：高次の保続の有無を評価
- 状況の変化に直面したときの柔軟さを測定する
- 128枚のカードを使用(日本版は負担軽減のため48枚のカードで施行され所要時間は約30分)
- 色・形・和が其々4種類あるカードを用意して被検者に示し、被検者は検者が答える正解・不正解の答えだけを手掛かりにして検者が考えている分類カテゴリーを推測(色or形or数)して提示された4枚のカードのいずれか1枚を選択する。
- 色・形・数のどの分類カテゴリーかは被験者に伝えない
- 検者は被検者が連続して正答したら(通常6回)、予告なしに分類カテゴリーを変更する



FAB: Frontal Assessment Battery

- 前頭葉機能の検査: 短時間・簡便に実施できる

概念化	次の2つはどのような点が似ていますか？ a. バナナ と ミカン
思考の柔軟性	「か」で始まる単語をできるだけたくさん言ってください。
運動系列	検者が片手で「グー ⇒ 手刀 ⇒ パー」を3回見せ、次に被験者にやらせよう。
葛藤指示	私が指で1回ポンと叩いたら、2回叩いてください。 私が2回ポンポンと叩いたら、1回叩いてください。
Go/No-Go課題	私が指で1回ポンと叩いたら、1回叩いてください。 私が2回ポンポンと叩いたら、叩かないでください。
把握行動	被験者の手のひらに検者の手をつけ、手を握らないでいられるかを観察する。

パーソナリティ検査

パーソナリティ検査の分類

質問紙法	十分な自覚を経た反応を見る
投影法	無意識を含めた反応を見る
描画法	投影法の一つ 心理面接で用いられる
作業検査法	作業成果からパーソナリティを判断

パーソナリティ検査： 質問紙法

- 簡便
- 十分な自覚を経た反応を見る

MMPI: ミネソタ多面人格検査

Minesota multiphasic personality inventory

- 1943年発表
- 当初の目的は、精神医学的診断を客観化すること
- 現在では、パーソナリティ理解の手段
 - 精神的・身体的健康、家族、職業、教育、性、社会、政治、宗教、文化などについての態度に関する**550個の項目**
- 2022年に日本語版が出版された最新版(MMPI-3)では335項目となり、最新の心理学・精神医学の知見を取り入れた内容になっている

1. 機械関係の雑誌が好きだ..... ☐
2. 食欲はある..... ☐
3. 朝、目がさめた時は、たいていよく休まったという感じがする..... ☐
4. 図書館の仕事（司書）をしてみたいと思う..... ☐
5. ゲーム（勝負事）には、負けるより勝ちたい..... ☐
6. 犯罪に関する新聞記事を読むのが好きだ..... ☐
7. ふだん、手足は温かい..... ☐
8. 毎日の生活は充実しているほうだ..... ☐
9. これまでと同じように、今も仕事ができる..... ☐
10. 選挙の時、よく知らない人に投票したことがある..... ☐
11. だれでも自分の見た夢の意味を知り、夢の教えに従うべきだ..... ☐
12. 推理小説や探偵小説はおもしろい..... ☐
13. 仕事をする時は、ひどく緊張する..... ☐
14. 月に何度も下痢をする..... ☐
15. 時たま、人に言えないようなことを考える..... ☐

MMPIの妥当性尺度 (受検態度を査定する)

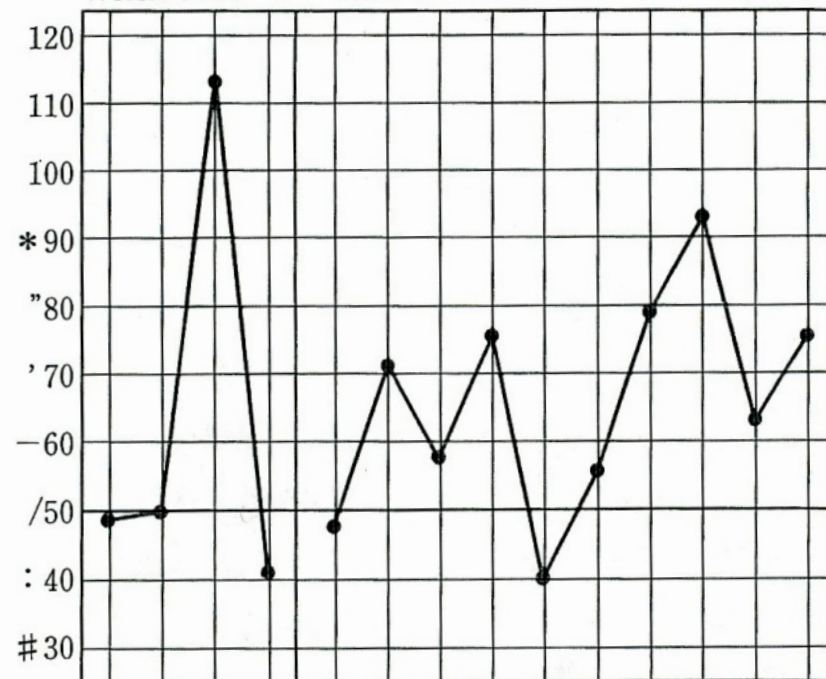
疑問点	不決断や否定的態度
虚構点	自分を好ましい方向に見せようとする傾向
妥当性得点	風変わりな回答や、自分を悪く見せようとする傾向
修正点	検査に対する防衛的傾向

MMPIの臨床尺度

(10種類。パーソナリティの特徴を表す)

心気症尺度	保守性・精神面の無視傾向・身体的訴えを使う場面回避
抑うつ尺度	現状への不満・不適応感・抑うつ気分
ヒステリー尺度	ストレス対処の仕方(否認や抑圧傾向)
精神病質的偏奇性尺度	人や制度などに逆らい闘う傾向、主張する傾向
性尺度	役割の柔軟性・性役割観
パラノイア尺度	対人関係での感受性・疑問を抱く傾向
精神衰弱性尺度	不安定
統合失調症性尺度	現実との接触の仕方・疎外感
軽躁病尺度	活動性
社会的内向性尺度	社会参加や対人接触を避ける傾向

Welsh code 8*"7402'9-36/15: F*"'-L/?K:



	?	L	F	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
					Hs	D	Hy	Pd	Mf	Pa	Pt	Sc	Ma	Si
粗点	2	5	25	11	14	33	26	32	39	11	41	49	23	51
T	49	50	113	41	48	71	58	76	40	55	79	93	63	76

追加尺度

	A	R	MAS	Es	Lb	Ca	Dy	Do	Re	Pr	St	Cn	Mt	MAC	O-H	As
粗点	29	26	29	34	15	21	28	14	25	13	17	27	31	15	15	11
T	74	66	70	33	60	68	57	43	58	56	45	59	74	35	46	39

他の情報

検査所要時間: 67分 T: F=234: 314 F-K=14
臨床 8 尺度の平均 T: 67.8 Goldberg 指数: 61

図 4 事例 1 の MMPI プロフィール

パーソナリティ検査： 投影法

- 無意識を含む反応を見る
- 総合的なパーソナリティ評価が可能

投影法

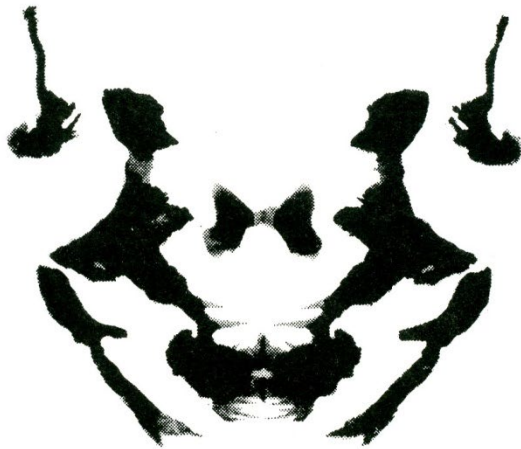
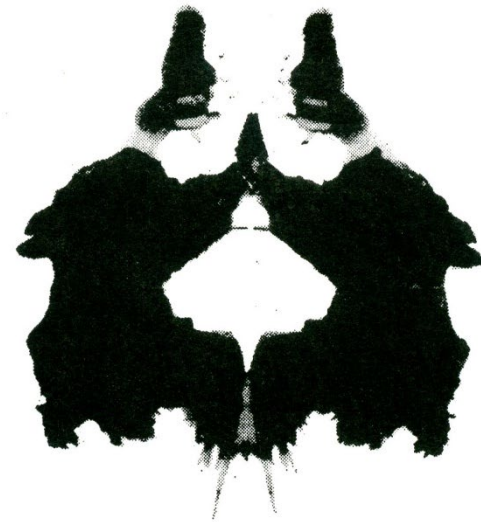
- 投影法は精神分析理論で解釈されるものではない
- 必ずしも抑圧された無意識の欲求や感情を表すものとは言えない
- 意識の濾過や内省を経ないという特徴は投影法の対象者の年齢の幅を広げている
- 多くは知的レベルによって実施が不可とはなりにくい
- 投影法は数量化がなされない検査であると誤解されているが、そうとは言えない。たとえばロールシャッハ・テストは数量化が非常に進んでいる投影法。

ロールシャッハ・テスト

- 1921年、スイスの精神科医Rorschachに始まる
- インクのしみの見方から被験者のパーソナリティを理解しようとする検査
- 思考障害の同定など鑑別診断の補助として精神科臨床でよく用いられる心理検査
- 左右対称のインクのしみ10枚(無彩色5枚、有彩色5枚)を、被験者に1枚ずつ見せて、何に見えるか自由に答えてもらう
- 主なものとしてクロッパース式、エクスナー式、片口式、阪大式、名大式、他がある
- 施行時間：60分以上

ロールシャッハ・テストの手順

- 2つの施行過程から成る
- はじめの**自由反応段階**では、10枚のカードを1枚ずつ被検者に見せて何に見えるか問う。
- 次の**質疑段階**では、其々の反応がカードのどこに、どのような特徴から見たのか被検者に説明してもらう
- 得られた反応を**領域**（インクのしみ全体をみているのか部分だけを見ているのか）、**決定因**（形態的特徴だけが手がかりなのか色彩や陰影を手がかりとして用いているのか、刺激にない動きをみているのか）、**内容**（見ているのは動物なのか人間なのか、花や物体なのか）、この3つのカテゴリーに分けて記号化する。



ロールシャッハ・テスト

- 記号化・分類されて量的に分析される

領域	インクのしみの全体を見ているか、部分を見ているか
決定因	手がかりが形態的特徴か、色彩か、陰影か、動きか
内容	見ているものは、動物か、人間か、花や木か

- 縦列分析(反応の流れ)、主題分析(反応に示された主題)、状況分析(被験者の行動)などを加えて総合的に分析される。
- 近年では複数の解釈ソフトが発売されている。

ロールシャッハ・テスト

- ロールシャッハ・テストの信頼性や妥当性など心理測定論的な問題を指摘する声は以前からあったが、どこまで統計的頑強性を求めるか意見が分かれる
- いっぽうで、ロールシャッハ・テストで認知機能を調べられるとの観点から、Perryらは記銘力障害の2症例を基にロールシャッハ・テストを神経心理学的検査として用いる場合のガイドラインを提唱している(1997)
- 石橋らは、ロールシャッハ・テストとfMRIによる脳機能との関連を調査(2012)

SCT: 文章完成テスト

Sentence Completion Test

- 未完成の刺激文に、被験者が自由に連想を働かせて文章を完成させる
- 精研式SCTはPart1とPart2から成り、各30問の計60項目で構成されている
- 被験者の感情の動きや態度、行動、対人関係の特徴などを把握しようとする検査
- 回答文を話題に面接が進められることもある

1 ^{ちい}小さい時, ^{とき}私は ^{わたし}私は _____

2 ^{ご はん}御飯のとき _____

3 ^{おとうと}弟は _____

^{いもうと}妹は _____

4 ^{がっこう}学校から ^{かえ}帰って ^{わたし}私は _____

5 どうしても ^{わたし}私は _____

6 ^{うん どう}運動 _____

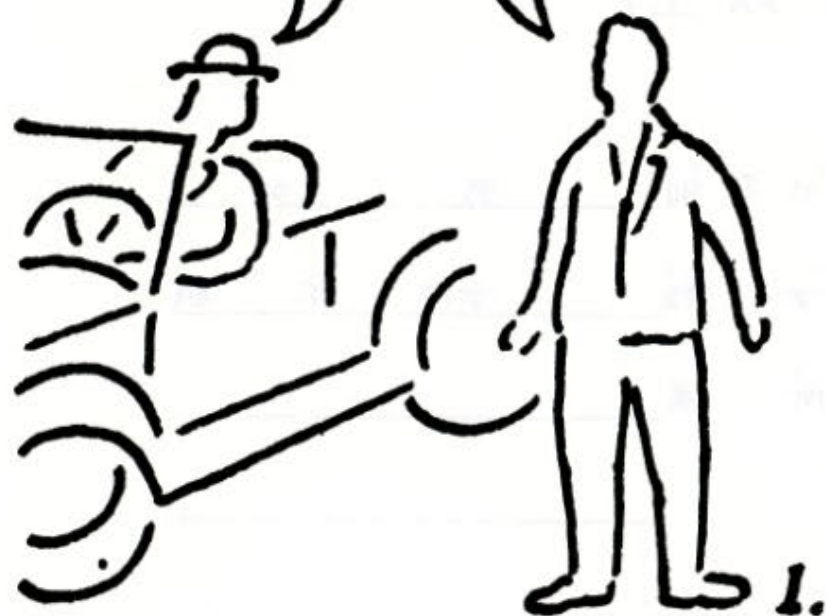
7 ^{わたし}私がきらいなのは _____

P-Fスタディ

Picture-Frustration Study

- 典型的な刺激場面(フラストレーション場面)を設定して、それに対しての被験者の反応の型からパーソナリティを理解しようとするもの
- 右側の人物のふきだしが空欄となっており、この人物がどのように答えているかを書き込んでもらう
- 24種類の漫画風の絵に書き込みを行い、所要時間は30分程度
- アグレッションの方向と型という2次元から解釈
- アグレッションの方向は、他責、自責、無責の3つ
- アグレッションの型は、欲求不満の状況を強調する障害優位型、欲求不満を直接表出する自我防衛型、欲求不満の解決を強調する要求固執型の3つ

服^{ふく}にはねを掛けて
しまって ほん
とうに すみませ
ん。できるだけ
水^{みず}だまりをよけ
て通^{とお}ろうとしたん
ですが——。



あら 大変^{たいへん}だわ!
あなた が 今^{いま}割^わっ
たのは、母^{はは}が大切^{たいせつ}
にしていた 花瓶^{かびん}
なんですよ。





図4 ある [redacted] のPFスタディへの反応例



図4 ある自閉症児のPFスタディへの反応例

P-Fスタディの新たな用途

- 日本ではアグレッションの表出ということから攻撃や敵意と結びつけられて解釈され、欲求が満たされないときの行動をみるという視点から矯正施設や児童相談所などで頻用されてきた。
- 近年は、描かれた日常生活の一コマから自閉スペクトラム症の対人関係や社会的認知の一端を理解しようとする試みがなされている。
- 自閉症児には文章として問題がないものの、方向と型の分類のどれにも当てはまらない評価不可能な反応が多いとの指摘がある。つまり場面全体に対する理解の仕方ではなく、その一部に対する断片的なものであったりすることから生じる結果である(田辺)。

パーソナリティ検査： 描画法

- 投影法の一つ
- 心理面接で用いられることが多い

主な描画法パーソナリティ検査

- バウム・テスト

- A4判の画用紙に柔らかい鉛筆で「1本の実のなる木」を描いてもらう

- HTP (House-Tree-Person)

- B5判の紙に、「家の絵」「1本の木」「一人の人(全身像)」を描いてもらう

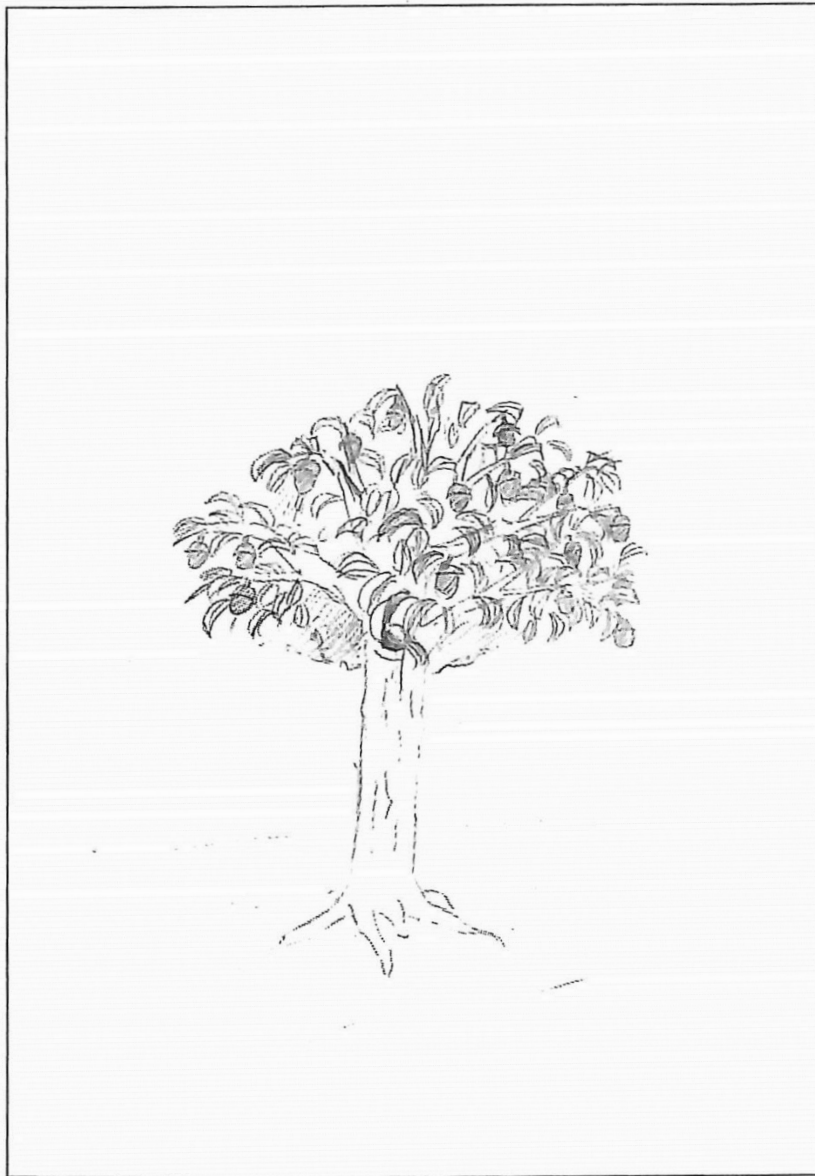


図1 バウムテスト (40代男性, 気分障害
大うつ病, 5回目セッション)

患者は

「絵を描くなんて中学校以来
だなあ。そういえば、私は若い
ときはマンガ家になろうと思っ
たんです。なぜか縮こまった
絵ですね。」

と感想を述べたことをきっか
けに自己理解を深めていった。

(増井、2010)

精神科臨床評価検査法マニュアル
(2010, アークメディア)

パーソナリティ検査： 作業検査法

- 作業に対する反応から性格特性を判断する

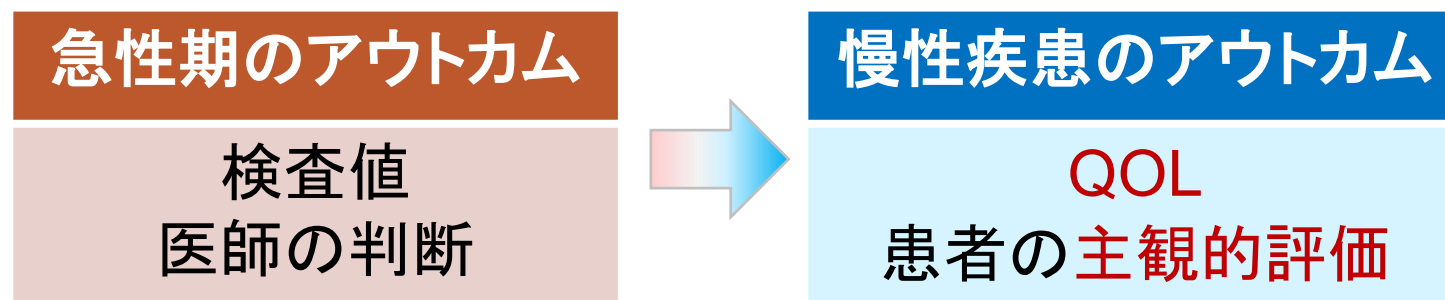
内田クレペリン精神作業検査

- 3～9の数字の隣どうしを加算し、一の位の答えを数字の間に次々と記入していく
- 作業量と作業曲線のプロフィールを中心に結果判定
- 他の心理検査ではつかみにくい「仕事ぶり」「作業ぶり」という面を明らかにしてくれる
- 広い意味での精神的健康度や精神障害の有無、様相、作業態度、作業の行い方(速さ、テンポ、注意力、持続性等)について知ることができる。しかし性格を多面的にとらえるのは困難
- 主に性格の意志的側面を把握することに限定して使用するほうが現時点では無難である

2. 症状評価尺度

慢性疾患とアンケート

- 現代医療は急性疾患から慢性疾患にシフト



- 患者報告式アウトカム (Patient-Reported Outcome)
 - 「患者の健康状態に関して、臨床家等の修正や解釈を介さない、患者から直接得られた報告による測定」¹⁾

自記式評価尺度による患者の「生の声」が指標

1. 米国FDA (2009) Guidance for Industry: Patient-Reported Outcome Measures: Use in Medical Product Development to Support Labeling Claims

どの評価尺度を使うべきか？

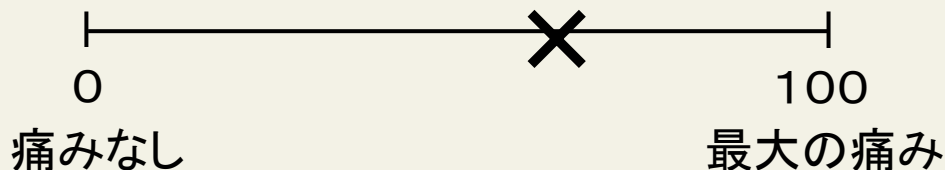
- 妥当性：測りたいものを測れているか？
- 信頼性：正確に測れているか？



妥当性・信頼性が証明された
世界標準の評価尺度を使う必要がある

- 例) VAS：痛みの強さの測定に用いる

VAS
(Visual Analog Scale)



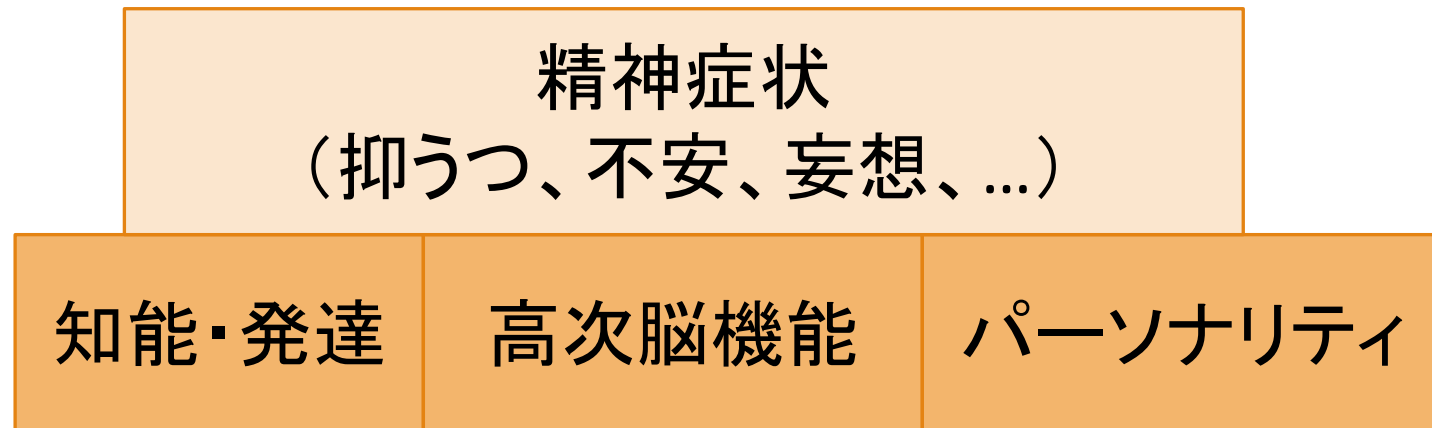
心理検査、症状評価尺度の関係

- 心理検査

- 精神疾患の「土台」となる「人となり」を評価する

- 精神症状評価尺度

- 妄想、気分、不安などの精神症状を評価する



精神症状評価尺度の利点

- 印象や勘に頼らない評価
 - 通常の診療を補完する
- 数量化して共有できる
 - 多職種チーム医療に適する
- 数量化して比較できる
 - 同一患者の縦断的評価に使用できる
 - 先行研究・データや、異なる文化圏とも比較可能

精神症状評価尺度の分類

● 形式による分類

- 自記式評価尺度 患者自身による評価を数量化
- 他者評価尺度 専門家による評価を数量化
- (半)構造化面接法 専門家による面接法

● 目的による分類

- スクリーニング
- 診断
- 重症度の測定 正常、軽症、中等症、重症
- 変化の測定 著明改善、中等度改善、...

主な評価尺度・面接法

	自記式評価尺度	他者評価尺度	(半)構造化面接法
スクリーニング	K6(不安症・うつ病) CES-D, PHQ-9(うつ病) PDS(PTSD) ASRS(ADHD) AQ(ASD)	MMSE(認知症) CAGE(アルコール依存)	
診断	精神疾患の診断は 専門家の面接が必要		MINI, SCID(精神疾患) CAPS(PTSD) CAADID(ADHD) ADI-R, ADOS-2(ASD)
重症度・ 変化の 測定	BDI-II, PHQ-9(うつ病) CAARS(ADHD)	PANSS, BPRS(統合失調症) YMRS(躁病) HAM-D, MADRS(うつ病) LSAS(社交不安症) Y-BOCS(強迫症) MMSE(認知症) ADAS(AD)	注) ASD: 自閉スペクトラム症 AD: アルツハイマー型認知症

自記式調査票： スクリーニング

K6

- Kesslerが開発
- 6項目、1～5段階評定
- うつ病・不安障害のスクリーニング
 - 14～24点 うつ病・不安障害の可能性
 - 9～13点 軽度の精神疾患の可能性

過去1ヶ月の状態	いつも	たい てい	とき どき	少し だけ	全く ない
神経過敏に感じましたか	4	3	2	1	0
絶望的だと感じましたか	4	3	2	1	0
そわそわ、落ち着かなく感じましたか	4	3	2	1	0
気分が沈み込んで、何が起こっても気が晴れないように感じましたか	4	3	2	1	0
何をするのも骨折りだと感じましたか	4	3	2	1	0
自分は価値のない人間だと感じましたか	4	3	2	1	0

CES-D

Center for Epidemiologic Studies Depression Scale

- アメリカの疫学研究で開発されてきたもの
- 目的：一般人口でのうつ病のスクリーニング
- 20項目、0～3点評価
- 標準カットオフ値は16点以上

のところを○でかこんで下さい。

	この一週間のうちに			
	な い	1-2日	3-4日	5日 以上
1. 普段は何でもないことがわずらわしい。	A	B	C	D
2. 食べたくない。食欲が落ちた。	A	B	C	D
3. 家族や友達からはげましてもらっても、気分が晴れない。	A	B	C	D
4. 他の人と同じ程度には、能力があると思う。	A	B	C	D
5. 物事に集中できない。	A	B	C	D
6. ゆうつだ。	A	B	C	D
7. 何をするのも面倒だ。	A	B	C	D
8. これから先のことについて積極的に考えることができる。	A	B	C	D
9. 過去のことについてくよくよ考える。	A	B	C	D
10. 何か恐ろしい気持ちがある。	A	B	C	D
11. なかなか眠れない。	A	B	C	D
12. 生活について不満なくすごせる。	A	B	C	D
13. ふだんより口数が少ない。口が重い。	A	B	C	D
14. 一人ぼっちでさびしい。	A	B	C	D
15. 皆がよそよそしいと思う。	A	B	C	D
16. 毎日が楽しい。	A	B	C	D

自記式調査票： 重症度・治療変化

BDI-II: ベックうつ病評価尺度

Beck's Depression Inventory - second edition

- 21項目、0～3点評価
- うつ病と診断された患者における、抑うつ症状の重症度評価
 - 0～13点 ごく軽度の抑うつ
 - 14～19点 軽度抑うつ
 - 20～28点 中等度抑うつ
 - 29～63点 重度抑うつ
- 治療による変化も評価可能

1. 悲しさ

- 0 わたしは気が滅入^{めい}っていない
- 1 しばしば気が滅入る
- 2 いつも気が滅入っている
- 3 とても気が滅入ってつらくて耐えがたい

2. 悲観

- 0 将来について悲観していない
- 1 以前よりも将来について悲観的に感じる
- 2 物事が自分にとってうまくいくとは思えない
- 3 将来は絶望的で悪くなるばかりだと思う

3. 過去の失敗

- 0 自分を落伍者^{らくご}だとは思わない
- 1 普通の人より失敗が多かったと思う
- 2 人生を振り返ると失敗ばかりを思い出す
- 3 自分は人間として完全な落伍者だと思う

4. 喜びの喪失

- 0 自分が楽しいことには以前と同じくらい喜びを感じる
- 1 以前ほど物事を楽しめない

6. 被罰感

- 0 自分が罰を受けているようには感じない
- 1 自分は罰を受けるかもしれないと思う
- 2 自分は罰を受けるだろう
- 3 自分は今罰されていると感じる

7. 自己嫌悪

- 0 自分自身に対する意識は以前と変わらない
- 1 自分自身に対して自信をなくした
- 2 自分自身に失望している
- 3 自分自身が嫌でたまらない

8. 自己批判

- 0 以前よりも自分自身に批判的ということはない
- 1 以前より自分自身に批判的だ
- 2 あらゆる自分の欠点が気になり自分を責めている
- 3 何か悪いことが起こると、全て自分のせいだと思う

9. 自殺念慮

- 0 自殺したいと思えることは少ない

STAI: 状態・特性不安検査

State-Trait Anxiety Inventory

- 状態不安と特性不安を別々に測定する
 - 状態不安: 特定の状況で感じる不安
 - 特性不安: 普段から感じる不安

他者評価尺度

統合失調症の他者評価尺度

- **PANSS** (Positive and Negative Syndrome Scale)
 - 統合失調症の状態像を総合的に把握する包括的評価尺度
 - 30項目
- **BPRS: 簡易精神症状評価尺度** (Brief Psychiatric Rating Scale)
 - 簡便に精神症状を包括・評価するために開発された
 - 18項目

BPRS: 簡易精神症状評価尺度

Brief Psychiatric Rating Scale

心氣的訴え	敵意
不安	猜疑心
情動的ひきこもり	幻覚
思考解体	運動減退
罪業感	非協調性
緊張	思考内容の異常
衒奇的な行動や姿勢	情動鈍麻
誇大性	興奮
抑うつ気分	失見当識

うつ病の他者評価尺度

- **HAM-D: ハミルトンうつ病評価尺度** (Hamilton Rating Scale for Depression)
 - 当初17項目であったが、後に24項目版が作成され、広く用いられている
- **MADRS** (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale)
 - 10項目で4段階評価
 - 薬物療法に反応しやすい症状で構成されている
- **注)うつ病は自記式評価尺度、他者評価尺度の両方がある**

躁病の他者評価尺度

- **YMRS: ヤング躁病評価尺度** (Young Mania Rating Scale)
 - 11項目で躁症状を評価

気分高揚	言語・思考障害
活動の量的・質的增加	思考内容
性的関心	破壊的・攻撃的行為
睡眠	身なり
易怒性	病識
会話(速度と量)	

認知症の他者評価尺度

- **MMSE** (Mini-Mental State Examination)
 - 認知症のスクリーニング、重症度分類用
 - 11問の質問で、見当識(時間、場所)、記憶(短期記憶、想起)、言語的能力(物品呼称、読字、言語理解、文章理解、文章構成)、図形認識などを調べる
- **ADAS** (Alzheimer's Disease Assessment Scale)
 - アルツハイマー型認知症の治療効果判定用
 - 11の下位検査

国試過去問(第109回E問題51)

30歳の女性。自閉的な生活を心配した両親に伴われて来院した。17歳ころ、周りの人が自分を避けるのは変な臭いがしているからだと言い始め、自室に閉じこもるようになったため精神科で治療を受けた。治療によって外出できるようになり作業所に通所していた。28歳ころから幻聴が出現し「噂話をされている。何かやろうとするといちいち文句を言われる」と言うようになり、再び外出することはなくなり、哲学書を繰り返し読むだけの生活になっていた。3か月前からは通院せず、服薬もしなくなったため、両親が転医を希望し新たな医療機関を受診した。診察時は感情表出に乏しく受動的で、断片的に幻覚や妄想を思わせる訴えが認められる。身体所見に異常を認めない。

統合失調症のケース

国試過去問(第109回E問題51)

この患者に対する心理・精神機能検査として有用でないのはどれか。

- a. バウムテスト
- b. Minnesota 多面人格検査〈MMPI〉
- c. Mini-Mental State Examination 〈MMSE〉
- d. ウィスコンシンカードソーティングテスト〈WCST〉
- e. 簡易精神症状評価尺度[Brief Psychiatric Rating Scale 〈BPRS〉]

国試過去問(第109回E問題51)

この患者に対する心理・精神機能検査として有用でないのはどれか。

a. バウムテスト

b. Minnesota多面人格検査〈MMPI〉

c. Mini-Mental State Examination 〈MMSE〉

d. ウィスコンシンカードソーティングテスト 〈WCST〉

e. 簡易精神症状評価尺度[Brief Psychiatric Rating Scale 〈BPRS〉]

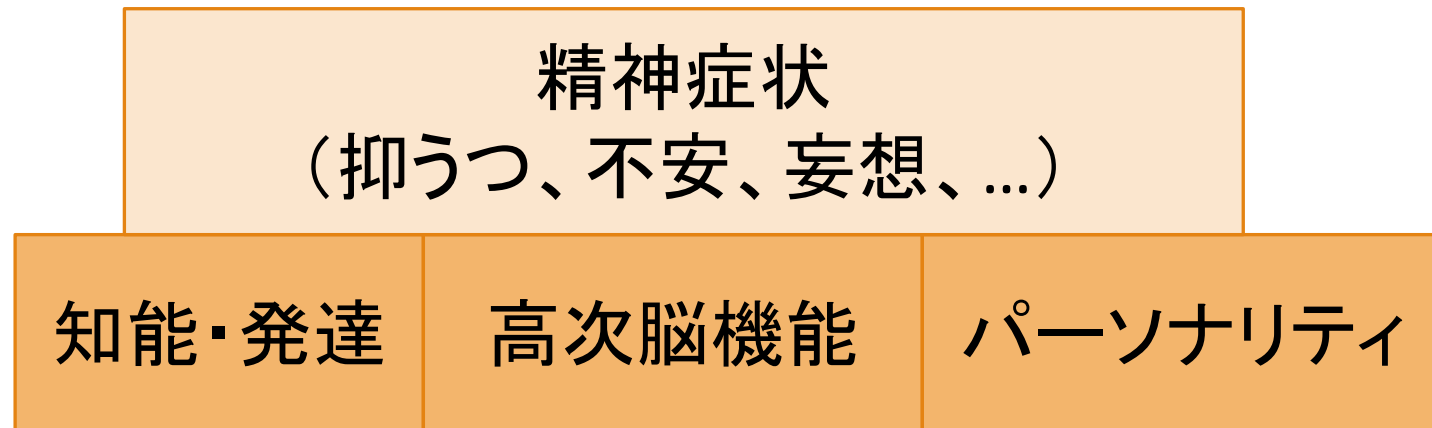
心理検査、症状評価尺度の関係

- 心理検査

- 精神疾患の「土台」となる「人となり」を評価する

- 精神症状評価尺度

- 妄想、気分、不安などの精神症状を評価する



(半)構造化面接法

精神疾患の構造化診断面接法

- **MINI** (Mini-International Neuropsychiatric Interview)
- **SCID** (Structured Clinical Interview for DSM)
 - いずれも臨床試験などで用いられる
 - 各症状に関して系統的に質問するように構成されている

SCID

Structured Clinical Interview for DSM

周りの人々が自分のことを話しているように見えたり，自分に特別に注意を払っているように見えたりしたことがありましたか？

「はい」なら：誰かがあなたのことを話していると確信していたり，それがあなたの想像であったと考えたことがありましたか？

テレビや，ラジオや，新聞から，あるいは周りで起こる事が仕組まれていて，特別なメッセージを受けたという経験は？

関係妄想，すなわち周囲の対象または出来事に対し，個人的意味を誤って関連づける

記述すること：

誰かがわざわざあなたをつらい目にあわせようとしたり、あなたを傷つけようとしたりしたことは？

被害妄想、すなわち個人（あるいはその個人の属するグループ）が攻撃され、脅かされ、欺かれ、迫害されている

記述すること：

あなたは過去にある点で、特別に重要な人物と感じたり、他の人々が出来ないことをできるという特別な力があると感じたことは？

誇大妄想、すなわち、力、知識または自己の重要性の誇大化に関する内容あるいは神か有名人と特別な関係などの内容

記述すること：

3. 画像検査

精神科領域の画像検査

- **脳形態画像 (CT, MRI)**

- 器質的疾患(脳腫瘍、脳血管障害など)を除外する
- 認知症性疾患における脳萎縮を判定し、診断補助に用いる

- **脳血流SPECT**

- 認知症性疾患における脳血流低下部位を判定し、診断補助に用いる

- **DATスキャン**

- 脳のドパミントランスポーター・シンチグラフィ
- レビー小体型認知症の診断に用いる

- **光トポグラフィー検査: NIRS (near-infrared spectroscopy)**

- 近赤外光を用いて、頭皮上から脳皮質の活動を計測
- うつ病、双極性障害、統合失調症の鑑別補助に使用可能

4. 生理検査

精神科領域の生理検査

● 脳波

■ 発作性症状の鑑別

- てんかん
- 心因性非てんかん発作、解離性けいれん

■ 意識障害の評価

- せん妄
- 昏迷：うつ病性昏迷、解離性昏迷